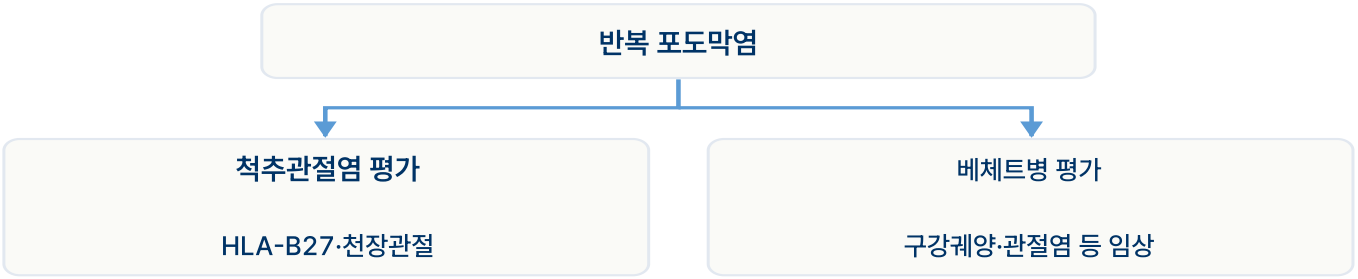
반복 포도막염 의뢰 환자

척추관절염(SpA)·베체트병 평가와 HLA 검사

반복 포도막염에서는 전신 증상이 뚜렷하지 않아도 척추관절염을 평가한다. HLA 검사는 임상 양상과 함께 해석한다.

핵심 판단의 흐름



척추관절염을 의심할 단서

평가 항목	강의의 임상 단서
축성 증상	천장관절 침범·염증성 요통. 젊은 나이, 서서히 시작, 3개월 이상의 만성 경과를 본다.
시간·활동 양상	아침에 심하고 운동·활동 후 호전, 휴식으로 호전되지 않음, 야간통·수면 중 각성.
관절 밖 단서	무릎·발목 관절염, 아킬레스건 부착부염, 건선, 염증성 장질환, 포도막염.

HLA 검사와 영상 — 연자 Q&A

검사	해석·적용
HLA-B27	축성 SpA/AS의 74–89%, 일반인의 <1%에서 양성. 양성자의 SpA 위험은 2–10% (약 5%). AS의 Odds ratio(OR) >50으로 제시. 일반인 선별검사로 사용하지 않는다.
천장관절 X-ray	염증성 요통이 뚜렷하지 않아도 강직성 척추염을 찾는 경우가 있어, 상황이 허락하면 시행이 도움된다.
HLA-B51	베체트병 민감도 약 50%, 일반인 양성 약 10–20%. 진단적 가치가 낮아 일반적 진단검사로 이용하기 어렵다.

진료실에서 기억할 점

포도막염의 반복 여부와 관절·피부·장 증상을 함께 정리한다. HLA 양성만으로 질환을 확정하지 않는다.